



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Круп'ярська, 27, м. Львів, 79014, тел. (032) 275-60-61, Е-
mail: lvivsescentr@gmail.com Сайт: www.ses.lviv.ua

Код ЄДРПОУ 38501853

24.03.23 р. № 810 /01

На № від

Керівникам закладів охорони здоров'я
Львівської області
незалежно від форми власності

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

«Про заходи щодо профілактики, діагностики та лікування кору»

Відповідно до наказу МОЗ України від 23.04.2019 №954 «Про затвердження порядку проведення епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом вродженої краснухи» клінічними критеріями випадку кору є наявність у хворого гарячки та макулопапульозної висипки і принаймні одного з таких трьох симптомів:

- кашель;
- гострий риніт (нежить);
- кон'юнктивіт.

Епідеміологічним критерієм випадку кору є епідеміологічний зв'язок - контакт з хворим з лабораторно підтвердженим випадком кору за 7 - 18 днів до появи висипки.

Визначення випадків кору:

- підозрілий випадок - випадок з ознаками та симптомами, що відповідають клінічним критеріям випадку кору.
- лабораторно підтверджений випадок - підозрілий випадок захворювання на кір, який відповідає критеріям лабораторного підтвердження випадку кору;
- епідеміологічно пов'язаний випадок - підозрілий випадок захворювання на кір, за якого не проведено адекватного лабораторного обстеження але який мав контакт з іншим лабораторно підтвердженим випадком кору за 7 - 18 днів до появи висипки;
- клінічно сумісний випадок - підозрілий випадок захворювання на кір, за якого не проведено лабораторного обстеження та для якого не встановлено епідеміологічного зв'язку з іншим лабораторно підтвердженим випадком;

- відхилений випадок - підозрілий випадок захворювання на кір, який був лабораторно обстежений та діагноз не було підтверджено у зв'язку з негативними результатами лабораторного дослідження або наявністю епідеміологічного зв'язку з лабораторно підтвердженим випадком іншого інфекційного захворювання.

Лабораторними критеріями випадку кору є принаймні один з таких чотирьох:

- виділення вірусу кору з клінічного матеріалу;
- виявлення РНК вірусу кору з клінічного матеріалу;
- поява IgG антитіл до вірусу кору в парних сироватках;
- виявлення IgM антитіл до вірусу кору.

Підозрілі випадки захворювання на кір у осіб з IgM антитілами до вірусу кору, які в період від 7 днів до 6 тижнів до забору проби клінічного матеріалу для лабораторного дослідження отримали щеплення вакциною проти кору та в яких висипка з'явилася протягом 7 - 14 днів після щеплення, надалі класифікуються як **відхилені**.

Спалах кору - лабораторно підтверджені 2 і більше випадків захворювання на кір, пов'язані між собою в часі (дати появи висипки в проміжках між 7 та 18 днями після контакту з хворим на кір), які мають епідеміологічний та/або вірусологічний зв'язок.

У разі виявлення хворого на кір, або осіб з підозрою на дану хворобу, медичні працівники юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми, фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики, та інших закладів і установ, які в ході виконання своєї діяльності отримують інформацію про стан здоров'я особи, зобов'язані протягом 12 годин повідомити центр контролю та профілактики хвороб шляхом подання Форми первинної облікової документації N 058/о "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року N 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560 (далі - Екстрене повідомлення).

У разі зміни діагнозу або категорії випадку за визначенням випадку медичні працівники всіх юридичних осіб протягом 12 годин після зміни діагнозу або категорії випадку подають нове Екстрене повідомлення зазначаючи первинний та змінений/уточнений/підтверджений діагноз, дату зміни, уточнення чи підтвердження діагнозу, результати лабораторних досліджень та інші дані, які стали підставою для зміни діагнозу.

Кожен випадок кору підлягає реєстрації та обліку за місцем виявлення у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування та інших закладах та установах (виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладах і закладах системи соціального захисту незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування) за Формою первинної облікової документації № 060/о "Журнал обліку інфекційних захворювань", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року N 1.

Відповідно до наказу МОЗ України № 1777 від 03.08.2020 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами» медичні працівники з негативним імунним статусом (відсутність набутого імунітету - відсутність даних щодо проведеної вакцинації або перенесеного захворювання на кір) не повинні проводити догляд

за пацієнтами з підозрою або підтвердженим кором.

Медичні працівники, які проводять догляд за пацієнтами з кором повинні носити респіратор класу захисту не нижче FFP3 (надягти до входу та зняти після виходу з приміщення, де перебуває хворий кором). У разі незахищеного (без надягнутого респіатора) контакту та негативного імунного статусу, показане проведення постконтактної вакцинопрофілактики у перші 72 години після контакту або введення імуноглобуліну людського нормального протягом 6 днів у відповідності до інструкції до препарату. Контактні особи мають бути ізолювані до 21 дня після останнього контакту або до моменту виписки.

В ЗОЗ необхідне швидке виявлення та ізоляція пацієнтів з підтвердженою або підозрюваною коровою інфекцією; дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю; розроблення і затвердження СОП щодо поводження із пацієнтом з підозрою або підтвердженим кором (наприклад, заходи із забезпечення ізоляції, заходи захисту під час транспортування, обстеження і поводження з контактними особами).

Підтвердженим є контакт у наступних випадках:

- 1) особа перебувала в одному повітряному просторі із хворим на кір без використання ЗІЗ органів дихання (респіратору класу захисту FFP3 і вище);
- 2) особа перебувала в повітряному просторі без використання ЗІЗ органів дихання (респіратору класу захисту FFP3 і вище), де перебував хворий на кір, але покинув його і пройшло менше двох годин (вірус кору зберігає свою вірулентність до двох годин в повітрі, за умови відсутності механізмів знезараження повітря).

В поліклінічних відділеннях та стаціонарах слід забезпечити позитивний імунний статус щодо кору у всіх працівників:

- 1) доказами наявності імунітету від кору у працівників ЗОЗ та ЗСЗ є:
письмовий запис щодо проведеної вакцинації двома дозами вакцини, яка містить вірус кору або лабораторні докази наявності імунітету (наявність підвищеного рівня IgG до вірусу кору в крові; сумнівний або невизначений результат слід вважати негативним), або лабораторно підтверджене перенесене захворювання, або народження до 1957 року;
- 2) під час спалаху кору медичним працівникам з негативним імунним статусом слід провести вакцинацію двома дозами вакцини, яка містить вірус кору.

Заходи щодо зведення до мінімуму потенційну взаємодію з вірусом кору:

- 1) до прибуття в ЗОЗ:
 - рекомендовано планувати зустрічі по телефону - для осіб з підозрою на кір надайте інструкції щодо необхідності надягання маски при вході, дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю; крім того надати інформацію який вхід у ЗОЗ використовувати та кого повідомити про прибуття;
 - повідомити медичних працівників про прибуття хворого (приблизний час його прибуття, маршрут, ЗІЗ органів дихання, які слід надягнути);
- 2) під час прибуття в ЗОЗ :
 - дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю, гігієни рук та розподілу потоків між пацієнтами і відвідувачами шляхом: розміщення візуальних оповіщень, забезпечення дезінфекційними засобами для гігієни рук і масками;

- працівникам, які зустрічають, одягнути на пацієнта маску (якщо це не зроблено до того і якщо це можливо) та додатково повідомити про необхідність дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю; дотримуватися визначеного маршруту.

Слід дотримуватися стандартних і заснованих на недопущенні інфікування кором заходів захисту:

- 1) дотримуйтеся стандартних заходів захисту при догляді за всіма пацієнтами;
- 2) дотримуйтеся повітряних заходів захисту при догляді за пацієнтом.

Розміщення пацієнта хворого кором:

- слід якомога швидше розмістити пацієнта в боксовану ізолювану палату (маску пацієнт може зняти поки знаходиться в палаті без присутності інших осіб);
- якщо боксована палата недоступна, слід якомога швидше транспортувати пацієнта у ЗОЗ в якому вона є (в очікуванні переведення пацієнта розмістіть його в окремій кімнаті/палаті з санвузлом та дверима, які щільно зачиняються; маску при перебуванні в такій кімнаті/палаті знімати не рекомендовано);
- після того як пацієнт покине кімнату/палату входити до неї протягом двох годин заборонено;

Медичні працівники повинні використовувати респіратори класу захисту не менше FFP3 (попередньо має бути проведене якісне тестування прилягання респіратора (фіт-тестування); респіратор необхідно надягати в незалежності від імунного статусу щодо кору; попередньо медичні працівники мають бути навчені і підготовлені щодо правильного користування респіратором (показання до надягання, правила надягання, носіння, зняття і утилізації);

Заходи захисту при транспортуванні:

- слід обмежити транспортування пацієнтів з підтвердженим/підозрюваним кором, окрім випадків нагальної необхідності (наприклад, для надання спеціалізованої допомоги, яка не може бути надана в умовах боксу);
- при транспортуванні: пацієнт має бути одягнений в маску, якщо це не протипоказано; слід використовувати завчасно визначений маршрут, що включає мінімальний контакт з людьми, які не забезпечують догляд за пацієнтом;
- якщо необхідно провести транспортування хворого кором за межі ЗОЗ, завчасно слід попередити приймаючих медичних працівників щодо його прибуття і щодо необхідності вжиття повітряних заходів захисту;

Тривалість реалізації повітряних заходів захисту:

- при догляді за пацієнтами з кором дотримуватися повітряних заходів захисту слід протягом 4 днів з моменту появи висипу (день появи висипу є 0 днем);
- при догляді за пацієнтами з кором та імунодефіцитом дотримуватися повітряних заходів захисту слід протягом всього періоду госпіталізації або до одужання, через більш тривале виділення вірусу у даної категорії хворих.

Обмеження перебування відвідувачів на території ЗОЗ :

- в разі появи випадків кору серед населення, слід розглянути можливість/необхідність проведення скринінгу на вході в ЗОЗ;
- відвідувати пацієнта з кором дозволено виключно особам з підтвердженим позитивним імунним статусом щодо кору;

Заходи щодо контактних осіб, в тому числі медичних працівників:

1) медичні працівники з підтвердженим позитивним імунним статусом щодо кору після контакту з пацієнтом хворим на кір, в тому числі незахищеним:

- постконтактної вакцинації не потребують;
- обмеження в роботі застосовуватися не повинні;
- мають проходити щоденний моніторинг ознак і симптомів кору протягом 21 дня після останнього контакту (слід пам'ятати, що імунні пацієнти можуть переносити кір в стерій або субклінічній формі);

2) медичні працівники без підтвердженого позитивного імунного статусу щодо кору після контакту з пацієнтом на кір:

- мають пройти постконтактну вакцинацію від кору протягом 72 годин після першого контакту;
- не допускаються до роботи з 5 дня після першого контакту до 21 дня після останнього контакту, в незалежності від отримання постконтактної профілактики;

- якщо медичний працівник отримав першу дозу вакцини від кору до контакту, він може продовжувати працювати і повинен отримати другу дозу вакцину через 28 днів після першої вакцинації (крім того, до такого працівника застосовується щоденний моніторинг ознак і симптомів кору протягом 21 дня);

3) медичних працівників, які хворі або підозрілі щодо захворювання на кір:

- слід відсторонити від роботи на 4 дні від появи перших елементів висипу (перший день появи висипу слід вважати 0 днем);
- медичних працівників, які входять до групи пацієнтів з імунodefіцитом, слід відсторонити від роботи на весь період хвороби;

4) заходи щодо пацієнтів без підтвердженого позитивного імунного статусу щодо кору після контакту з пацієнтом на кір:

- мають пройти постконтактну вакцинацію від кору протягом 72 годин після першого контакту;
- мають бути поміщені в ізольовану палату на 21 день після останнього контакту або до моменту виписки;
- слід повідомити центр контролю та профілактики хвороб про контактних пацієнтів, які плануються на виписку, з метою продовження нагляду за ними.

Заходи з локалізації та боротьби із спалахом:

1) слід негайно повідомити відділ інфекційного контролю (ВІК) про можливий або підтверджений спалах кору;

2) ВІК, із врахуванням місцевого контексту, має розробити план розміщення пацієнтів з кором (наприклад, госпіталізація виключно в бокси або когортна ізоляція);

3) в незалежності від методу ізоляції (індивідуальна або когортна) пацієнтів з кором слід розміщувати окремо (окрема будівля, окрема система вентиляції частини будівлі) від пацієнтів з групи ризику розвитку ускладнень кору;

4) рекомендовано використовувати тимчасові вентиляційні рішення для забезпечення негативного тиску в кімнаті/палаті, де знаходяться пацієнти з кором (наприклад, витяжні вентилятори).

Навчання і підготовка медичних працівників:

1) в програму навчання і підготовки включити компонент щодо профілактики передавання та інфікування кору;

2) слід провести навчання і підготовку працівників щодо користування респіраторів (показання до надягання, правила надягання, носіння, знімання і утилізації);

3) необхідно провести перевірку теоретичних і практичних знань працівників перед тим, як допустити їх до проведення догляду за пацієнтами з кором.

Слід впровадити механізми негайного інформування відповідального за програми інфекційного контролю працівника (ВІК та керівництво ЗОЗ) про поступлення або звернення за медичною допомогою пацієнта з кором;

За наявності протипоказів до введення корової вакцини або у разі недоступності останньої контактним проводиться пасивна імунопрофілактика кору - введення внутрішньом'язово 10 % імуноглобуліну людського нормального.

Пасивна імунопрофілактика кору проводиться якомога раніше після моменту контакту з хворим на кір, оптимально - в перші 6 діб (екстрена імунопрофілактика після 6 діб від моменту контакту має меншу ефективність, але може модифікувати тяжкість перебігу кору).

Пасивна імунопрофілактика кору шляхом введення людського імуноглобуліну нормального 10 % показана дітям до 1 року, ВІЛ-позитивним особам, вагітним, особам з первинними імунодефіцитами, пацієнтам, які отримують імуносупресивну терапію.

Введення вакцини проти кору можливе не раніше ніж через 6 місяців після пасивної імунопрофілактики.

Контакт з інфекційним хворим, у тому числі з хворим на кір, та встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів щодо будь-якої інфекційної хвороби не є протипоказаннями до планової та екстреної вакцинації. Наявність контакту у реципієнта вакцини з вагітною жінкою або імунокомпрометованою особою не є протипоказом до вакцинації проти кору.

За особами, які контактували з хворими на кір встановлюється медичне спостереження протягом 21 доби після виявлення останнього випадку захворювання в осередку.

У навчальних, оздоровчих закладах, закладах з цілодобовим перебуванням дітей чи дорослих медичне спостереження за особами, що контактували з хворим на кір, здійснює медичний працівник відповідного закладу. У домашніх осередках кору медичне спостереження за контактними особами здійснює лікар, з яким особа уклала Декларацію про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги.

У направленні на госпіталізацію хворих або осіб з підозрою на кір додатково до анкетних даних зазначають початкові симптоми хвороби, інформацію про профілактичні щеплення, а також дані епідеміологічного анамнезу.

Допуск дітей, що хворіли на кір до навчальних закладів здійснюється лише після їх повного видужування та з документальним підтвердженням згідно з Формою первинної облікової документації № 095/о "Довідка про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу I - IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад", затверджена наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 696/21009.

У разі реєстрації спалаху кору у навчальному закладі для дітей чи дорослих з цілодобовим перебуванням з моменту виявлення першого хворого до 21 дня з моменту виявлення останнього хворого не приймаються особи, що не хворіли на кір або особи, які не отримали щеплення.

Особи, що контактували з хворим на кір які не мають документального підтвердження про отримання необхідної за віком кількості доз вакцини проти кору або про захворювання на кір в анамнезі, не допускаються до планової госпіталізації до закладів охорони здоров'я, крім інфекційних лікарень та

інфекційних відділень лікарень, протягом усього періоду медичного спостереження.

Госпіталізація осіб, які перебувають під медичним спостереженням як контактні на кір, здійснюється до визначених закладів охорони здоров'я за життєвими показами, при цьому в лікарні організовуються додаткові протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню інфекції.

Проведення лабораторної діагностики:

1. У разі реєстрації поодиноких випадків захворювання (з урахуванням економічної доцільності) матеріал від хворих з підозрою на кір направляється до найближчої лабораторії з діагностики кору та краснухи, у т.ч. Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
2. З метою успішного виконання програми елімінації кору проводиться лабораторне дослідження зразків сечі та назофарингеальних змивів від осіб з підозрою на кір для ізоляції та генотипування вірусів. Зразки сечі та назофарингеальних змивів відбирають не пізніше третьої доби від моменту появи висипки.
3. Проби сечі та носоглоткового змиву необхідно відібрати у хворого не пізніше третьої - четвертої доби від появи висипки з дотриманням таких вимог:
 - 1) зібрати 50 - 100 мл сечі першої ранкової порції в стерильний посуд, охолодити зразок до + 4° С;
 - 2) для збору назофарингеального змиву прополоскати горло 3 - 5 мл фізіологічного розчину та зібрати промивні води в стерильну пробірку;
 - 3) із пробірки з назофарингеальним змивом перенести надосадову рідину в окрему стерильну пробірку типу "Епандорф" або пластикову пробірку з кришкою, що нагвинчується;
4. Усі відібрані зразки з метою генотипування необхідно доставити до лабораторії для дослідження з дотриманням "холодового ланцюга" за температури +2 - +8° С протягом 24 годин. Упаковка зразків проводиться згідно з вимогами щодо транспортування інфікованих матеріалів.
5. Кожний зразок етикетується із зазначенням епідеміологічного номера, дати відбору та типу зразка (сеча, назофарингеальний змив) і поміщається в поліетиленовий пакет з адсорбуючим матеріалом та обов'язково супроводжується направленням в окремому поліетиленовому пакеті. Зразок та направлення вкладаються в один контейнер.
6. У разі лабораторного підтвердження мінімум двох випадків кору - спалаху всі наступні випадки захворювання можуть бути підтверджені на підставі епідеміологічного зв'язку з лабораторно підтвердженим випадком.
7. Лабораторно підтверджуються всі підозрілі випадки кору у вагітних жінок.
8. У разі продовження спалаху кожні 2 місяці проводиться лабораторне дослідження мінімум 5 проб клінічного матеріалу від хворих на кір для визначення циркулюючого генотипу вірусу кору.

Згідно наказу МОЗ України від 16.09.2011 № 595 зі змінами планова вакцинація проти кору проводиться у віці 1 рік та 6 років. Щеплення з порушенням календаря можна розпочинати у будь якому віці. Мінімальний інтервал між введенням доз вакцини становить 1 місяць.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
11.09.2017 № 1082

ІНСТРУКЦІЯ

щодо організації та проведення додаткових заходів з імунізації серед дитячого населення віком від 12 місяців до 8 років 11 місяців 29 днів

Кількість доз КПК в анамнезі	Тактика щодо вакцинації КПК дітей віком 1 рік - 8 років 11 міс. 29 діб	Тактика вакцинації КПК у випадку контакту з хворим на кір	Тактика за наявності протипоказань до вакцинації КПК	Тактика щодо щеплених КПК, що перебувають в контакті з особами, які мають протипоказання до вакцинації КПК (вагітні, імуносупресовані, інші)
0 доз (дитина не щеплена)	Ввести одну дозу КПК. Введення другої дози КПК - вакцинація за віком згідно до календаря щеплень, але не раніше ніж один місяць від попередньої дози КПК.	Ввести одну дозу вакцини КПК в перші 72 години**	Проводити пасивну імунопрофілактику у випадку контакту з хворим на кір*	Після вакцинації КПК розмежування не проводиться.
1 доза (дитина щеплена однією дозою)	Вік дитини до 6 років: вакцинація за віком згідно до календаря щеплень	Ввести другу дозу вакцини КПК незалежно від віку, але не раніше ніж через один місяць від попередньої дозы КПК		
	Вік дитини старше 6 років: ввести другу дозу КПК з мінімальним інтервалом 1 місяць від першої дози КПК			
2 дози (дитина щеплена двома дозами)	Не проводити вакцинацію КПК	Не проводиться		

*Пасивна імунопрофілактика проводиться шляхом внутрішньо/м'язового введення препарату

Імуноглобуліну нормального людини рідкого (далі - Імуноглобуліну). Введення Імуноглобуліну необхідно здійснити якомога раніше після моменту контакту, оптимально - в перші 6 діб. Введення Імуноглобуліну після 6 діб від моменту контакту має меншу ефективність, але може модифікувати тяжкість перебігу кору. Дозування препарату Імуноглобуліну у відповідності до Інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

****Якщо минуло більше 72 годин, слід провести вакцинацію КПК якомога раніше, що забезпечить імунітет на майбутнє у випадку неінфікування.**

Лікування кору у дітей: Наказ № 354 від 09.07.2004 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей (редакція від 01.09.2021р.)

**З повагою,
генеральний директор**



Наталія ІВАНЧЕНКО